

Heridas — Cierre primario, secundario y por tercera intención

1. Introducción y relevancia clínica

El **cierre de heridas** constituye una de las decisiones quirúrgicas más frecuentes y críticas en la práctica clínica. No se trata solo de “suturar”, sino de **elegir el momento y método adecuados** que favorezcan una cicatrización rápida, funcional y estética, evitando complicaciones como **infección, dehiscencia o cicatriz patológica**.

En urgencias y cirugía general, es fundamental **reconocer el tipo de herida y decidir su manejo temporal (cierre primario, secundario o por tercera intención)**. La correcta selección depende de factores como el **grado de contaminación, tiempo transcurrido, vitalidad tisular, localización anatómica y estado del paciente**.

En Chile, las guías quirúrgicas del **MINSAL** y los protocolos IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención de Salud) enfatizan que un cierre apropiado es tan importante como la asepsia, antisepsia y el desbridamiento.

Para efectos de EUNACOM, el tema suele aparecer como pregunta conceptual o de manejo clínico inmediato ante heridas traumáticas.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La **cicatrización de una herida** es un proceso fisiológico que ocurre en tres fases superpuestas:

1. **Inflamatoria (0–3 días)**: hemostasia, infiltrado neutrofílico, fagocitosis.
2. **Proliferativa (3–21 días)**: fibroblastos, colágeno tipo III, angiogénesis, epitelización.
3. **Remodelación (21 días–12 meses)**: colágeno tipo I, maduración, contracción.

El tipo de **cierre** influye directamente en la duración y resultado estético del proceso.

2.1 Conceptos clave de cierre

Tipo de cierre	Definición	Características
Primario (por primera intención)	Aproximación inmediata de los bordes de la herida.	Heridas limpias, con bordes viables, sin infección.
Secundario (por segunda intención)	La herida queda abierta para sanar desde el fondo hacia la superficie por tejido de granulación.	Heridas contaminadas, infectadas o con pérdida de tejido.
Tercerario (cierre diferido o por tercera intención)	La herida se deja abierta 48–72 h tras limpieza/desbridamiento y se cierra si no hay signos de infección.	Intermedio entre los dos anteriores; útil en heridas traumáticas sucias o mordeduras.

2.2 Principios generales de elección

- La **infección** y la **necrosis tisular** son las principales contraindicaciones de cierre inmediato.
- **El tiempo no es absoluto**, pero orienta: en heridas limpias, el cierre primario puede realizarse hasta 12–18 horas (24 h en cara).
- La **perfusión tisular** y el **control de contaminación** son más importantes que el reloj.
- Heridas contaminadas o traumáticas extensas deben **irrigarse y reevaluarse antes del cierre** (tercera intención).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

En este contexto, la “clínica” se centra en **identificar si la herida está apta para cierre inmediato** y detectar signos que **obligan a postergar o evitar el cierre**.

3.1 Herida apta para cierre primario

- Bordes **nítidos y viables** (rosados, bien perfundidos).
- **Ausencia de infección o supuración.**
- **Tiempo <12 h** (hasta 24 h en cara).
- Tejido circundante sano, sin hematomas ni cuerpos extraños.
- Buena **hemostasia** lograda.
- Paciente sin factores mayores de riesgo (DM descompensada, inmunosupresión severa).

3.2 Herida no apta para cierre inmediato

- Contaminación evidente o **tejido desvitalizado.**
- Presencia de **pus, exudado o mal olor.**
- **Aplastamiento, avulsión o pérdida de sustancia.**
- Mordeduras (especialmente en mano), heridas punzantes profundas o por arma de fuego.
- Sospecha de **cuerpo extraño** o exposición articular.
- Paciente con compromiso sistémico o mala perfusión local.

3.3 Diagnóstico diferencial

- **Celulitis** vs inflamación normal posttraumática.
- **Hematoma o seroma** vs absceso incipiente.
- **Dehiscencia** vs cicatrización retardada.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

No existen pruebas específicas para determinar el tipo de cierre, pero **apoyan la evaluación global de la herida:**

Examen	Utilidad
Radiografía	Detección de cuerpos extraños o fracturas subyacentes.
Ecografía	Evaluar colecciones o trayectos fistulosos.
Cultivo de secreción	Solo si hay signos clínicos de infección.
Laboratorio (hemograma, PCR)	Infección sistémica o heridas complicadas.
Criterio diagnóstico principal → valoración clínica: contaminación, viabilidad tisular y tiempo desde la lesión.	

5. Tratamiento (según guías MINSAL y cirugía general)

5.1 Cierre primario (primera intención)

Indicaciones

- Heridas limpias o limpias-contaminadas.
- Bordes viables y aproximables sin tensión.
- Sin signos de infección ni necrosis.
- <12–18 horas (hasta 24 horas en cara).

Técnica

1. **Asepsia y antisepsia** del campo.
2. **Anestesia local** (lidocaína ± adrenalina).
3. **Irrigación a presión** (≥500 mL SSF 0.9%).

4. **Desbridamiento selectivo** de bordes no viables.
5. **Hemostasia** meticulosa.
6. **Sutura** por planos (preferir materiales monofilamento absorbibles en planos profundos y no absorbibles para piel).
7. **Apósito estéril oclusivo**.

Ejemplos típicos

- Cortes limpios por cuchillo o vidrio.
- Heridas quirúrgicas planificadas.
- Laceraciones faciales limpias.
- Incisiones de drenaje programadas.

Ventajas

- Cicatrización rápida (7–10 días).
- Menor costo y molestias.
- Mejor resultado estético.

Desventajas

- Riesgo de infección si cierre inapropiado o contaminación inadvertida.

5.2 Cierre secundario (segunda intención)

Indicaciones

- Heridas **infectadas, contaminadas o con pérdida tisular**.
- Mordeduras contaminadas, abscesos drenados, úlceras o avulsiones.
- Imposibilidad de aproximar bordes sin tensión.

Técnica

- Dejar la herida **abierta**.
- Limpieza diaria o curaciones con solución salina estéril.
- Desbridamiento progresivo hasta lograr tejido de granulación sano.
- Posible uso de **curaciones húmedas interactivas** (espuma, hidrogel, alginato).
- En algunos casos, posterior cobertura con **injerto o colgajo**.

Ventajas

- Permite control de infección y drenaje continuo.
- Evita cierre sobre tejido contaminado.

Desventajas

- Cicatrización más lenta.
- Mayor cicatriz.
- Necesidad de controles frecuentes.

5.3 Cierre por tercera intención (diferido o retardado)

Indicaciones

- Heridas **muy contaminadas, traumáticas o por mordedura**.
- Heridas con **tejido dudoso** tras desbridamiento inicial.
- Situaciones donde se requiere observar evolución antes de cerrar.

Técnica

1. **Desbridamiento amplio e irrigación abundante.**
2. Dejar la herida **abierta** con apósito estéril.
3. **Curaciones diarias** durante 48–72 horas.

4. Si no hay infección ni supuración → realizar **cierre diferido** (sutura o injerto).
5. Si aparecen signos de infección → continuar con curaciones hasta resolución y cierre secundario.

Ejemplos

- Mordedura de perro en mano.
- Herida por aplastamiento con tejido marginal dudoso.
- Trauma abdominal con contaminación fecal.

Ventajas

- Combina la seguridad del cierre abierto con la estética del cierre primario.
- Permite evaluar viabilidad y evitar infección.

Desventajas

- Requiere reevaluación constante y manejo hospitalario.

5.4 Elección del tipo de cierre según zona anatómica

Zona	Tolerancia al cierre	Consideraciones
Cara y cuero cabelludo	Alta	Buena irrigación, puede cerrarse hasta 24 h después.
Cuello y tronco	Media	Evaluar contaminación y tensión.
Manos y pies	Baja	Alta tasa de infección; preferir cierre diferido.

**Periné y región
genital**

Baja

Contaminación frecuente, riesgo de
anaerobios.

5.5 Criterios de éxito del cierre

- Ausencia de signos de infección o necrosis.
 - Aproximación sin tensión.
 - Buena perfusión de bordes.
 - Sutura correcta y retirada oportuna.
 - Cicatrización continua en 7–14 días.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones más frecuentes

- **Infección de herida:** por cierre precoz en contexto contaminado.
- **Dehiscencia:** por tensión o material inadecuado.
- **Cicatriz hipertrófica o queloide:** predisposición genética, tensión en línea de sutura.
- **Necrosis de bordes:** por compresión o cierre bajo tensión.
- **Mala estética o retracción funcional.**

6.2 Prevención

- Cierre solo en condiciones de asepsia.
- Irrigación abundante.
- No cerrar heridas dudosas o sucias.

- Selección correcta de material y técnica de sutura.
- Educación del paciente y control postoperatorio.

6.3 Pronóstico

- Cierre primario: curación en 7–10 días.
- Cierre terciario: 10–14 días tras cierre diferido.
- Cierre secundario: semanas a meses, dependiendo del tamaño y localización.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **El tipo de cierre no depende del tiempo**, sino del **grado de contaminación y vitalidad tisular**.
2. **Cara y cuero cabelludo** se pueden cerrar hasta 24 h post trauma por su rica irrigación.
3. **Mano, pie, periné y mordeduras**: preferir **cierre diferido o secundario**.
4. El **cierre diferido (tercera intención)** es clave en heridas traumáticas sucias o por aplastamiento.
5. **Infección y necrosis** son **contraindicaciones absolutas** para cierre primario.
6. **No cerrar heridas con cuerpos extraños, supuración o dudas de viabilidad**.
7. En EUNACOM, el distractor clásico es “cerrar herida sucia tras lavado”; la respuesta correcta es **diferir el cierre**.



Errores comunes

- Cerrar heridas contaminadas creyendo que la irrigación es suficiente.
 - Olvidar reevaluar la herida a las 48–72 h (cierre diferido).
 - Aplicar exceso de tensión sobre bordes → necrosis.
 - No reconocer una herida infectada antes del cierre.
 - Ignorar la importancia del **tejido de granulación** como indicador de salud tisular.
 - Usar materiales inadecuados (multifilamentos en heridas sucias → retienen bacterias).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Cierre primario:** inmediato, para heridas limpias/incisas con bordes viables.
2. **Cierre secundario:** herida abierta que cicatriza por granulación; indicado en heridas sucias o con pérdida de tejido.
3. **Cierre por tercera intención:** se deja abierta 48–72 h tras limpieza; se cierra luego si no hay infección.
4. La **infección y necrosis** son contraindicaciones absolutas para cierre primario.
5. **Cara** tolera cierre tardío (hasta 24 h); **manos, pies y periné** prefieren cierre diferido.
6. La **evaluación clínica** (contaminación, perfusión, tejido viable) guía la decisión, no el tiempo por sí solo.
7. **EUNACOM clásico:** “¿Qué tipo de cierre corresponde a una herida contaminada tras desbridamiento inicial?” → **Tercera intención.**